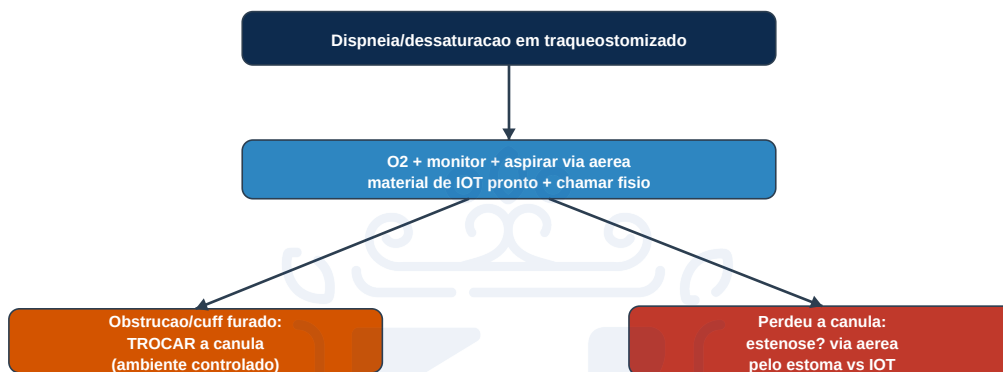


## PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO — EMERGÊNCIAS

### FLUXOGRAMA — DESCONFORTO RESPIRATÓRIO NO TRAQUEOSTOMIZADO

#### TRAQUEO — OBSTRUÇÃO OU PERDA DE CÂNULA



### PRIMEIRO: POR QUE O PACIENTE TEM TRAQUEOSTOMIA?

#### ENTENDER O CONTEXTO

- Investigar o motivo: estenose de traqueia, síndrome, AVC/TCE prévio, uso de CPAP/BIPAP, criança
- Familiares de paciente crônico geralmente sabem cuidar — não vão ao PS por bobeira
- NÃO dar alta sem entender exatamente o que está acontecendo; encaminhar se necessário
- A causa muda a conduta na perda de cânula (ver adiante)

### RED FLAGS — EMERGÊNCIA DE VIA AÉREA

#### AGIR IMEDIATAMENTE

- Sinais de obstrução da cânula ou cuff furado com dessaturação
- Sempre em ambiente controlado: O2, monitorização e material de IOT disponíveis
- Aspirar a via aérea ANTES de qualquer troca
- Chamar ajuda (fisioterapia / especialista) precocemente
- DICA DE OURO: no sufoco, é mais fácil passar um TOT pequeno (5,0-6,5) pelo estoma do que uma cânula nova

### TROCA DE CÂNULA — TÉCNICA

#### Rx OBSTRUÇÃO / CUFF FURADO

Posicionar em decúbito dorsal, pescoço estendido, boa exposição cervical

Aspirar a via aérea antes da troca

Forma comum: retirar a cânula antiga e já inserir a nova com xilocaína gel na ponta

Inserir a ponta de forma LATERAL e depois rodar 90 graus para a posição correta

Alternativa: guiar a troca por sonda (nasogástrica) introduzida pela cânula antiga

Ter SEMPRE mais de um tamanho de cânula à disposição

## REGRA DE OURO DO TAMANHO

### NUNCA AUMENTAR O CALIBRE NO PS

- NUNCA tente colocar cânula MAIOR do que a que o paciente usa
- Ex.: usa plástica 7,5 -> trocar por 7,5 ou 7,0; NÃO passar 8,0
- Cânula maior que não entra deve ser deixada para o especialista
- Se a nova cânula não passar -> usar o TOT pequeno pelo estoma como resgate

## PERDA DE CÂNULA — A CAUSA DECIDE A VIA AÉREA

### Rx TEM ESTENOSE DE TRAQUEIA

Estenose é PROXIMAL ao estoma (entre cordas e traqueostoma)  
IOT pela boca tende a ser muito difícil/ineficaz  
Estabelecer via aérea PELO ORIFÍCIO da traqueostomia  
Resgate: TOT pequeno (5,0-6,5) pelo estoma

### Rx SEM DOENÇA TRAQUEAL

Traqueo por causa neurológica/síndrome (via aérea alta pérvia)  
Preferir INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL se necessário  
Encaminhar a serviço com cirurgia torácica  
Estabilizar e transferir com via aérea garantida

## TIPOS DE CÂNULA

| Tipo     | Características                                                               | Perfil do paciente                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Plástica | Pode ter cuff e/ou endocânula; sem endocânula = alto risco de rolha/obstrução | Necessita cuff: VNI domiciliar ou proteção contra broncoaspiração |
| Metálica | Sem cuff; SEMPRE tem endocânula; curta/média/longa; numeração 0-6             | Neurológico bom, não precisa proteger via aérea                   |

## EQUIVALÊNCIA DE NUMERAÇÃO (METÁLICA x PLÁSTICA)

### REFERÊNCIA RÁPIDA

- A endocânula serve para o paciente retirar e limpar várias vezes/dia (evita rolha)
- Metálica 4 média ~ equivale à plástica 7,0
- Metálica 5 média ~ equivale à plástica 8,0
- A maioria dos pacientes usa a versão média

## CHECKLIST PÓS-PROCEDIMENTO / ANTES DA ALTA

### CONFIRMAR

- ☐ Cânula pérvia, bem posicionada e fixada; SatO2 adequada
- ☐ Causa do evento esclarecida e resolvida (obstrução/cuff/perda)
- ☐ Aspiração eficaz e via aérea protegida conforme necessidade
- ☐ Orientação ao cuidador sobre sinais de obstrução e higiene da endocânula
- ☐ Encaminhamento a especialista (cirurgia torácica/ORL) se troca complexa ou doença traqueal

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente traqueostomizado por \_\_\_\_ (causa), apresentou \_\_\_\_ (obstrução / cuff furado / perda de cânula).
- Conduta: aspiração + troca de cânula nº \_\_\_\_ / via aérea estabelecida por \_\_\_\_ (estoma/IOT).
- Doença traqueal: sim/não. Via aérea atual: \_\_\_\_ | SatO2: \_\_\_\_.
- Solicito avaliação de \_\_\_\_ (cirurgia torácica / ORL) e \_\_\_\_ (vaga/transferência).



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente usa cânula plástica 7,5. Apresenta obstrução e a cânula 7,5 não passa na troca. Qual a conduta mais segura no PS?

- A) Forçar uma cânula 8,0 para garantir calibre
- B) Tentar cânula menor (7,0) ou, no sufoco, passar um TOT pequeno pelo estoma
- C) Aguardar o especialista sem nenhuma via aérea
- D) Intubar pela boca obrigatoriamente
- E) Realizar nova traqueostomia cirúrgica imediata

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com ESTENOSE de traqueia perde a cânula de traqueostomia e está em insuficiência respiratória. Qual a melhor estratégia de via aérea?

- A) Intubação orotraqueal pela boca, que será fácil
- B) Estabelecer via aérea pelo orifício da traqueostomia (a estenose é proximal ao estoma)
- C) Ventilação com máscara facial indefinidamente
- D) Aguardar transferência sem intervenção
- E) Cricotireoidostomia acima da estenose

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Antes de qualquer troca de cânula em ambiente de PS, qual medida é indispensável?

- A) Iniciar antibiótico profilático
- B) Garantir O<sub>2</sub>, monitorização e material de IOT disponíveis, e aspirar a via aérea
- C) Sedação profunda do paciente
- D) Radiografia de tórax prévia obrigatória
- E) Jejum de 8 horas

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre os tipos de cânula, assinale a correta:

- A) A cânula metálica possui cuff e é usada para ventilação positiva domiciliar
- B) A cânula plástica sem endocânula tem baixo risco de obstrução
- C) A cânula metálica não tem cuff, sempre tem endocânula e é usada em paciente neurológico bom
- D) A endocânula impede a aspiração da via aérea
- E) Toda cânula plástica é metálica internamente

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente traqueostomizado por sequela neurológica (sem doença traqueal) perde a cânula e precisa de via aérea. Conduta preferencial?

- A) Via aérea exclusivamente pelo estoma
- B) Intubação orotraqueal e encaminhamento a serviço com cirurgia torácica
- C) Não há indicação de via aérea
- D) Forçar a recolocação de uma cânula de maior calibre
- E) Traqueostomia cirúrgica imediata no PS

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Regra de ouro: nunca aumentar o calibre no PS. Se a cânula do mesmo número não passa, tentar uma menor (7,0); no sufoco, o resgate mais fácil é um TOT pequeno (5,0-6,5) pelo estoma. Cânula maior fica para o especialista.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na estenose traqueal, a obstrução é proximal ao estoma (entre cordas e traqueostoma), tornando a IOT pela boca ineficaz. A via aérea deve ser estabelecida pelo próprio orifício da traqueostomia.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Toda troca de cânula deve ser feita em ambiente controlado: O<sub>2</sub>, monitorização e material de IOT prontos, com aspiração prévia da via aérea e ajuda (fisioterapia/especialista) disponível.

### QUESTÃO 4 → Resposta: C

Metálica: sem cuff, sempre com endocânula, para paciente neurológico bom que não precisa proteger via aérea. Plástica sem endocânula tem ALTO risco de obstrução. Cuff/VNI domiciliar = cânula plástica com cuff.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

Sem doença traqueal (via aérea alta pérvia), a perda de cânula deve ser manejada preferencialmente por intubação orotraqueal, com encaminhamento a serviço com cirurgia torácica para reabordagem do estoma.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico